

1. The correct answers are: Un déficit en apoB100, Une mutation gain de fonction de la PCSK9, Un syndrome néphrotique
2. The correct answers are: Peut être liée à l'excès de poids, Est fréquemment de type IV, Peut se normaliser avec l'équilibration d'un diabète
3. The correct answers are: Est une douleur symptôme, Peut-être plurifactorielle
4. The correct answer is: Est à éviter en cas de chiffres tensionnels élevés
5. The correct answer is: VPO-VHA
6. The correct answers are: Un examen à J60 du patient, Une classification finale des cas de PFA par un comité national
7. The correct answers are: La combinaison à un adjuvant, La nature vivante de l'antigène vaccinal
8. The correct answers are: Hydrochlorothiazide, Laxatif, Indapamide
9. The correct answers are: La baisse de la PaCO₂ provoque une alcalose métabolique ce qui entraîne une diminution de la sécrétion des ions H⁺, L'hormone antidiurétique augmente l'excrétion urinaire de NH₄⁺ dans le tube collecteur cortical, L'aldostérone augmente l'excrétion urinaire de NH₄⁺ dans le tube collecteur, L'hyperkaliémie provoque une diminution de l'utilisation de la glutamine responsable d'une baisse de l'excrétion rénale de NH₄⁺
10. The correct answers are: Le système tampon ne consomme pas d'énergie, Le système tampon protéines est le système tampon le plus abondants
11. The correct answers are: Nausées et vomissements, Troubles de la conscience
12. The correct answers are: La déplétion volémique stimule la soif, La déplétion volémique stimule l'hormone antidiurétique, L'angiotensine II stimule le mécanisme de la soif
13. The correct answers are: La réabsorption de l'eau se fait principalement à travers des aquaporines de type 1 non contrôlée par l'hormone antidiurétique, Le glucose est réabsorbé en totalité au niveau du TCP
14. The correct answers are: Administration du calcium par voie intraveineuse, Administration d'insuline ordinaire avec du sérum glucosé, Furosémide par voie intraveineuse
15. The correct answers are: Insuffisance rénale chronique avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/m, Une insuffisance surrénalienne
16. The correct answers are: Foramen Magnum, Canal de l'hypoglosse, Foramen Jugulaire
17. The correct answers are: la boîte crânienne est inextensible, Les mécanismes de compensation face à un volume surajouté (masse) obéissent à la loi de Monroe-Kellie, Le volume des secteurs artériels et parenchymateux reste toujours inchangé, Si les mécanismes de compensation sont dépassés, la pression intra-cranienne augmente
18. The correct answers are: L'hydrocéphalie fait partie des ACSOC, Les ACSOS sont la conséquence des troubles cardiorespiratoires et métaboliques, Les conséquences de l'hypertension intra-cranienne sont les engagements
19. The correct answers are: Dans la zone d'autorégulation cérébrale, le débit sanguin cérébral reste constant et ceci grâce à la vasomotricité des artéioles pie-mériennes, Les cascades de Rosner représentent la relation entre la pression artérielle moyenne, la pression de perfusion cérébrale et la pression intra-cranienne quand l'autorégulation est conservée, L'hypocapnie vasoconstrictrice est un facteur d'ischémie cérébrale avec réduction du débit sanguin cérébral, La pression artérielle moyenne supérieure à 150 mmHg entraîne une hyperhémie
20. The correct answer is: Propres à l'Homme
21. The correct answers are: Déficit en Facteur V, Echange plasmatique pour un purpura thrombotique
22. The correct answers are: Une leucémie aiguë, Un lymphome hodgkinien
23. The correct answers are: La sphérocytose héréditaire, La thrombocythémie essentielle, La forme double hétérozygote drépano- thalassémie
24. The correct answers are: Aspect nécrotique, Evolution par poussées
25. The correct answers are: Cryoglobulinémie, Syndrome de Sjogren
26. The correct answers are: Le myélogramme montre la présence de nombreux mégacaryocytes, La présence d'une anémie n'exclue pas le diagnostic, L'administration d'immunoglobulines polyvalentes est proposée en cas de syndrome hémorragique sévère
27. The correct answers are: Purpuras Fulminans méningococciques, Endocardites, Rickettsioses, Sepsis compliqué de CVID
28. The correct answer is: Une exploration de la protéine ADAMTS (activité et anticorps anti-

ADAMTS13)

29. The correct answers are: Le caractère extensif, Le purpura fébrile, Le caractère ecchymotique, Le caractère nécrotique
30. The correct answers are: La maladie de Bernard Soulier, L'Insuffisance rénale chronique, L'Insuffisance hépato-cellulaire, La prise d'AINS
31. The correct answer is: Aucune exploration
32. The correct answers are: Une anémie normochrome normocytaire arégénérative, Une thrombopénie
33. The correct answer is: La toxoplasmose
34. The correct answers are: L'habitat à Kairouan, L'âge inférieur à 5 ans
35. The correct answers are: Métronidazole en prise unique, Tinidazole en prise unique
36. The correct answers are: Les pertes vaginales verdâtres nauséabondes, Le prurit vulvaire, La dyspareunie
37. The correct answers are: Fasciite nécrosante streptococcique, Staphylococcie maligne de la face, Ethmoïdite aigue, Lymphangite
38. The correct answers are: Une diminution de la pression oncotique capillaire, Une augmentation de la perméabilité capillaire, Un blocage à l'évacuation par le réseau lymphatique, Une réabsorption tubulaire rénale primitive du sodium
39. The correct answer is: Interstitiel
40. The correct answers are: Une diminution de la Pression oncotique, Une dénutrition
41. The correct answers are: La douleur est due à l'augmentation brutale de la pression dans les cavités rénales en aval du calcul, Les AINS permettent de réduire les pressions dans les cavités rénales, La douleur évolue par poussée, La restriction hydrique permet de soulager la douleur
42. The correct answers are: Diminuent l'œdème et l'inflammation pariétal, Favorisent la baisse de la filtration glomérulaire, Favorisent la baisse de la pression intra cavitairer
43. The correct answers are: Aspect macroscopique jaune clair, Récidivantes, Résistants à la LEC
44. The correct answers are: La nucléation, La croissance cristalline, La rétention des cristaux
45. The correct answers are: Glycosamino-glycane, Les Pyrophosphates, Protéine de Tamm-Horsfall, Citrate
46. The correct answer is: Favorisés par la résection de l'intestin grêle
47. The correct answers are: De couleur brunâtre, De petite taille
48. The correct answers are: Cystinique, Struvite
49. The correct answers are: Une antibiothérapie récente par une céphalosporine de 2^{ème} génération, Une hospitalisation dans les 3 derniers mois, La présence d'une sonde à demeure, Une vie en institution
50. The correct answer is: La naloxone
51. The correct answers are: Il se manifeste par un élargissement du QRS à l'électrocardiogramme, L'allongement de QT est la première anomalie électrique détectée, Le bicarbonate de Sodium est le traitement de référence
52. The correct answers are: Une tachycardie, Des fasciculations musculaires, Une stimulation sympathique
53. The correct answers are: La femme enceinte, La survenue d'un état de mal convulsif suite à l'intoxication, Les enfants de bas âge
54. The correct answer is: L'absence du myxoœdème
55. The correct answers are: NFS, électrocardiogramme
56. The correct answers are: La macroglossie, La dépilation axillo pubienne, L'asthénie
57. The correct answers are: Une hyperuricémie, Une Anémie, Une augmentation de TSH
58. The correct answers are: L'hyperthyroïdie est liée à l'effet toxique de l'iode sur les thyrocytes, La scintigraphie est blanche
59. The correct answers are: Peut être d'origine virale, Peut être d'origine auto-immune
60. The correct answer is: Le taux de TSH est bas et le taux de FT4 est normal
61. The correct answer is: Bloque la résorption osseuse ostéoclastique
62. The correct answers are: Elle stimule la réabsorption tubulaire du calcium, Elle stimule l'ostéolyse
63. The correct answer is: Une hyperparathyroïdie primaire
64. The correct answers are: La calciurie peut-être élevée au cours de l'hyperparathyroïdie primaire, La calciurie est élevée au cours de l'ostéolyse métastatique
65. The correct answers are: Hyperthyroïdie périphérique, Sarcoïdose, Hyperparathyroïdie primaire

66. The correct answers are: Activité myogénique des fibres musculaires lisses, Rétrocontrôle tubuloglomérulaire
67. The correct answer is: De vasodilatation de l'artériole afférente et vasoconstriction de l'artériole efférente
68. The correct answers are: Le Système rénine angiotensine systémique, Le système nerveux sympathique, Le FAN
69. The correct answers are: Le Facteur atrial natriurétique, L'Ag II locale, Les catécholamines
70. The correct answers are: La contraception par une pilule œstro-progestative, L'obstruction des voies urinaires, L'exercice physique
71. The correct answers are: Sont sensibles à la quantité de NaCl dans le fluide tubulaire, Sécrètent un médiateur paracrine qui entraîne une vasoconstriction de l'artériole afférente
72. The correct answers are: Au cours d'un EDC hémorragique, la dette en oxygène est compensée initialement par une augmentation de l'extraction de l'oxygène au niveau cellulaire, L'acidose métabolique observée au cours de l'EDC hémorragique explique la polypnée observée., La non restauration d'une perfusion tissulaire correcte au cours de la réanimation d'un EDC hémorragique risque d'entraîner un EDC réfractaire
73. The correct answer is: Ce patient présente un EDC hémorragique stade II.
74. The correct answers are: L'agressivité, Les troubles mnésiques
75. The correct answer is: Une hypoglycémie qui nécessite l'intervention d'une tierce personne pour être reconnue et/ou traitée
76. The correct answers are: Anticorps anti-glutamate acide décarboxylase (anti-GAD), Anticorps anti-ZnT8
77. The correct answers are: La déshydratation extracellulaire est prédominante, Le mouvement de l'eau se fait du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire
78. The correct answers are: La déshydratation intracellulaire est prédominante, Pas de mouvement d'eau entre le secteur intracellulaire et le secteur extracellulaire, Le choc hypovolémique est fréquent
79. The correct answer is: Une intoxication à l'atropine
80. The correct answers are: Elle est calculée selon la formule de Parkland qui est la plus utilisée, Une majoration des besoins de 30 à 50 % est prévisible lorsque s'associent à la brûlure un traumatisme ou des lésions d'inhalation de fumée.
81. The correct answers are: Un choc hypovolémique par plasmorragie interne et plasmorragie extériorisée, Associée à une augmentation des résistances vasculaires systémiques, Associée à une baisse de la saturation veineuse centrale en oxygène($S_{vcO_2} < 65\%$)
82. The correct answers are: Une sécrétion intense et prolongée de catécholamines endogènes, Un catabolisme musculaire et une protéolyse, une hyperglycémie, une production hépatique accrue des protéines de l'inflammation
83. The correct answers are: Les brûlures profondes cicatrisent en 3 étapes: détersion, bourgeonnement, épithélialisation, L'infection est la complication majeure de brûlures graves
84. The correct answers are: L'exposition aux fumées d'incendie, L'âge avancé, Un traumatisme crânien associé
85. The correct answers are: Les vésicules séminales doivent être enlevées en même temps en monobloc, Est une intervention à risque hémorragique
86. The correct answer is: Est lymphophile et ostéophile
87. The correct answer is: L'oxygénothérapie
88. The correct answers are: L'insuffisance respiratoire aiguë, Le pneumothorax, La déshydratation aiguë
89. The correct answers are: La toux, Le freinage expiratoire, La dyspnée
90. The correct answers are: La fièvre peut être absente du tableau clinique, Le traitement est médico-chirurgical, L'atteinte peut être multifocale
91. The correct answers are: Une échographie est demandée à la recherche d'un épanchement, Une radiographie normale n'élimine pas le diagnostic, Il existe un syndrome inflammatoire biologique, La ponction articulaire permet la confirmation diagnostique
92. The correct answers are: une arthrotomie avec lavage articulaire et drainage, une immobilisation du membre, une antibiothérapie à large spectre adaptée ensuite à l'antibiogramme, une bithérapie à forte dose
93. The correct answers are: Présence d'un Pincement de l'interligne articulaire, Présence d'une

Lacune épiphysaire, Refoulement des parties molles, Présence d'une luxation articulaire

94. The correct answers are: Le staphylocoque est le germe le plus incriminé dans les arthrites septiques, Le traitement de l'arthrite septique est médico-chirurgical, L'antibiothérapie doit être probabiliste puis adaptée à l'antibiogramme
95. The correct answers are: Les antécédents de mort néonatale chez le frère, La mélanodermie, L'ambiguïté sexuelle
96. The correct answers are: Une diarrhée, Une pyélonéphrite aigue, La prescription de phénobarbital
97. The correct answers are: Une prostate augmentée de volume, Une prostate lisse et régulière, Un effacement du sillon médian
98. The correct answers are: Contexte de polyarthrite rhumatoïde, Fièvre, Malobservance au traitement
99. The correct answer is: La Ferritine
100. The correct answers are: Traitement de la polyarthrite rhumatoïde, Education de la patiente
101. The correct answers are: Arthrite septique de la hanche droite, Ostéomyélite du col fémoral
102. The correct answers are: Echographie de la hanche, Radiographie du bassin
103. The correct answers are: Ostéomyélite du fémur distal droit, Arthrite septique du genou droit
104. The correct answers are: Une échographie du genou, Une radiographie du genou
105. The correct answers are: Les palpitations, L'amaigrissement, L'hypocholestérolémie
106. The correct answers are: L'âge et le sexe de la patiente, L'antécédent de maladie cœliaque, L'évolution des signes cliniques évocateurs d'hyperthyroïdie depuis un an
107. The correct answers are: Si les anticorps antirécepteurs de la TSH sont positifs, Si la scintigraphie montre une hyperfixation diffuse et homogène du radioisotope
108. The correct answer is: Cholinergique
109. The correct answer is: Un dosage de l'activité anticholinestérasique plasmatique
110. The correct answers are: Atropine, Le méthyl sulfate de pralidoxime
111. The correct answers are: L'état des pupilles, Le dosage de l'activité cholinestérasique, La surveillance de l'ECG, La surveillance de l'équilibre hydroélectrolytique
112. The correct answer is: 12
113. The correct answer is: Traumatisme crânien modéré
114. The correct answer is: Scanner cérébral
115. The correct answers are: Les signes de localisation, Etat de conscience (GCS), Etat des pupilles, La Pression artérielle
116. The correct answer is: β Thalassémie majeure
117. The correct answer is: Electrophorèse de l'Hb
118. The correct answers are: Le groupe sanguin avec phénotypage, Bilan infectieux
119. The correct answers are: Transfusion, Antibiothérapie, Supplémentation en folates
120. The correct answers are: Le syndrome polyuropolydipsique, La glycémie veineuse à jeun à 2,1 g/L
121. The correct answer is: Le diabète de type MODY
122. The correct answers are: Un apport quotidien en glucides de 200 à 250 g/j, Une diminution de la consommation des aliments à index glycémique élevé
123. The correct answers are: TDonner du PPSB (facteurs de coagulation) à la dose de 25 UI/kg et contrôler le bilan d'hémostase une heure après la fin de perfusion, On peut donner du PFC à la dose de 20cc/kg
124. The correct answer is: Carence en vitamine B12
125. The correct answers are: La glossite de Hunter, Le signe de Romberg, Le signe de Babinski
126. The correct answers are: Le dosage vitaminique, Le myélogramme
127. The correct answer is: Supplémentation en Vitamine B12 en intramusculaire
128. The correct answers are: L'intensité des manifestations est proportionnelle à la durée et à la difficulté de la réanimation, L'atteinte est multiviscérale, Après récupération, les deux systèmes coagulation/anticoagulation, fibrinolyse/antifibrinolyse sont activés
129. The correct answers are: Leur correction rapide augmente les chances de récupération, La constatation d'une hypothermie impose un réchauffement, Une exsufflation est le premier geste à réaliser devant un pneumothorax suffocant, Une hypokaliémie peut être retrouvée
130. The correct answers are: Enregistrer au moins 20 cm de chaque dérivation, Compléter par les dérivations basales pour diagnostiquer un infarctus postérieur